

会阴尿道造口术

患者须知 · 在会阴部建立永久性排尿开口

WARWIKI

会阴尿道造口术在会阴部（阴囊与肛门之间的区域）建立一个新的、永久性的排尿开口。适用于尿道狭窄、瘢痕过重或损伤严重、无法修复的情况。术后，您将坐位通过此开口排尿，而非从阴茎尖端排出。本须知介绍其原理、准备事项及术后预期。

关于这项手术

狭窄是尿道上一段瘢痕化、变窄的区域，会阻碍尿液流出。当狭窄段较长、修复后反复复发，或尿道损伤过重无法重建时，医生会将**狭窄后方健康的尿道**引至会阴皮肤，并缝合固定，形成新的永久开口，尿液从此处排出。

这是一种**可靠、持久**的解决方案，可避免更复杂或反复的重建手术——对于复杂狭窄，或不希望多次手术的患者，是一个好的选择。

须知事项

最主要的改变是：您将**坐位排尿**，尿液从新开口流出，不再从阴茎尖端排出。大多数男性适应良好，满意度高。**阴茎保持原位**——感觉和性高潮通常不受影响，大多数男性勃起功能也得以保留（少数可能有所改变）。随着时间推移，开口可能**变窄**；若发生，通常可通过小手术再次扩开。

名词解释

尿道

将尿液从体内导出的管道。

狭窄

尿道上瘢痕化、变窄的区段，阻碍尿液流出。

会阴

阴囊与肛门之间的区域，即新开口所在位置。

会阴尿道造口术

将尿道引至会阴部建立永久开口的手术。

造口

尿液排出体外的新开口。

造口狭窄

新开口随时间逐渐变窄——通常可通过小手术处理。

导尿管

术后留置一至两周、待开口愈合期间使用的软管。

全身麻醉

手术期间使您处于睡眠状态、无痛感的药物。

会疼吗？ 手术在全身麻醉或脊椎麻醉下进行，过程中无任何感觉。术后会阴部会有1至2周的肿胀、淤青和酸痛——温水坐浴、冰敷和止痛药可缓解。手术中会放置导尿管。许多患者当天或住院一晚后即可回家。

如何准备（术前）

- 手术在**全身麻醉或脊椎麻醉**下进行——请遵守所有手术须知（禁食，以及需要暂停的药物，包括抗凝药）。
- **尿液检查**排除感染（如有感染须先治疗）；术前会使用抗生素。**请勿吸烟**——吸烟会延缓愈合。
- 手术时双腿将放在托架上。请做好**留置导尿管约1至2周**的准备，并安排人接送回家。

请提前告知您的医疗团队，如果您：

- 曾接受过**盆腔放疗**——新开口发生狭窄的风险更高
- 正在服用抗凝药，或目前存在感染

手术过程

- 1 麻醉后您处于睡眠或无感觉状态，双腿放在托架上；同时给予抗生素。
- 2 医生在会阴部切开，找到狭窄后方的健康尿道，切除或绕过瘢痕段。
- 3 将健康尿道引至皮肤并缝合固定，形成宽阔的新开口；放置导尿管后缝合伤口。

术后

- 会阴部会有1至2周的**肿胀、淤青和酸痛**。温水坐浴、冰敷和止痛药可缓解；保持该区域清洁。
- **导尿管留置约1至2周**，由医疗团队取出。之后您将**坐位**通过新开口排尿。
- 遵医嘱，数周内**避免重体力劳动、用力排便、骑车和性生活**，并避免直接压迫该区域。
- 若尿流**随时间减弱**，可能是开口在变窄——请告知医疗团队，通常可通过小手术重新扩开。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 导尿管脱出或不引流，或取管后**无法排尿**
- 发热或畏寒，或伤口处红肿、疼痛加重或有分泌物
- 大量出血

需要记住的三件事

1. 会阴尿道造口术在会阴部建立永久性排尿开口——适用于尿道狭窄或损伤过重无法修复的情况。术后您将**坐位**排尿。
2. 该手术持久可靠，可避免更复杂或反复的手术。**阴茎保持原位**；感觉和性高潮通常不受影响，大多数男性勃起功能得以保留。
3. 导尿管留置约1至2周。开口可能随时间变窄——若尿流减弱请告知医疗团队。出现发热、大量出血或排尿困难请立即就医。